

R. D. Spielberger
R. L. Gorsuch
R. E. Lushene



STAI

Cuestionario de **ANSIEDAD** Estado-Rasgo

ADAPTACIÓN ESPAÑOLA:

G. Buela-Casal

A. Guillén-Riquelme

N. Seisdedos Cubero



MANUAL



TEA *Ediciones*

STAI

Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo

C. D. Spielberger
R. L. Gorsuch
R. E. Lushene

Adaptación española:

Gualberto Buela-Casal
Alejandro Guillén-Riquelme
Nicolás Seisdedos Cubero

MANUAL

(8ª edición revisada y ampliada)



PUBLICACIONES DE PSICOLOGÍA APLICADA
Serie menor núm. 124

Publicado por TEA Ediciones, S.A., según acuerdo con el propietario original
CONSULTING PSYCHOLOGISTS PRESS, Inc. (California, USA) que se reserva todos los derechos

MADRID 2011

Título original

*"STAI, Manual for the State-Trait Anxiety Inventory
(Self Evaluation Questionnaire)"*

La adaptación española del STAI es obra de GUALBERTO
BUELA-CASAL, ALEJANDRO GUILLÉN-RIQUELME Y NICOLÁS
SEISDEDOS CUBERO.

La adaptación original del cuestionario fue realizado por
NICOLÁS SEISDEDOS CUBERO.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

Copyright © 1970 by CPP, Consulting Psychologists Press, Inc., California, USA.

Copyright de la edición española © 1982, 1986, 1988, 2002, 2008, 2011 by TEA Ediciones, S.A., Madrid, España.

I.S.B.N.: 978-84-15262-26-8
Depósito legal: M-31.966 - 2011

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
1. DESCRIPCIÓN GENERAL	9
1.1. Ficha técnica	9
1.2. Fundamentación y datos históricos	10
1.3. Descripción de las escalas	11
1.4. Justificación de la nueva edición y adaptación	12
1.5. Finalidad y aplicaciones	13
1.6. Material	14
2. NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN	15
2.1. Instrucciones para la aplicación	15
2.2. Obtención de las puntuaciones A/E y A/R	16
3. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA	19
3.1. Estudios originales	19
3.2. Adaptación española: fiabilidad y validez	23
A) Elementos y escalas: fiabilidad y valor discriminativo	24
B) Validez e intercorrelaciones del STAI	26
C) Análisis factoriales	28
4. NORMAS INTERPRETATIVAS	35
4.1. Muestras de tipificación	35
4.2. Conversión de valores directos en puntuaciones transformadas	36
4.3. Obtención de puntuaciones en factores adicionales	36
4.4. Grupos clínicos	37
BIBLIOGRAFÍA	39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de muestras originales	20
Tabla 2. Fiabilidad test-retest en alumnos universitarios.....	21
Tabla 3. Correlaciones entre el STAI A/R y otras medidas de ansiedad	21
Tabla 4. Correlaciones del STAI A/R y A/E con otras pruebas	23
Tabla 5. Análisis de ítems para varias muestras (normales y clínicas), medias de las escalas y fiabilidad (datos de la nueva edición y adaptación)	25
Tabla 6. Correlaciones entre el STAI A/R y A/E con las escalas del 16 PF Forma A	27
Tabla 7. Saturaciones factoriales de los 40 elementos del STAI (se han señalado con un signo negativo los que niegan ansiedad) en las cuatro dimensiones	29
Tabla 8. Saturaciones factoriales de los ítems del STAI en muestra general (datos de la nueva edición y adaptación)	31
Tabla 9. Estadísticos en la afirmación/negación del Estado/Rasgo dentro del STAI (muestra de tipificación)	32
Tabla 10. Baremos en centiles y decatipos para ansiedad estado y rasgo. Adolescentes y Adultos, Varones y Mujeres.....	38

Introducción

En la sociedad actual, caracterizada por un ambiente más globalizado y cambiante, donde las demandas sociales son cada vez mayores, los términos de estrés y ansiedad no son desconocidos para nadie. Así, el concepto de ansiedad está muy extendido en la sociedad, estableciéndose como un término de uso casi cotidiano.

Desde la perspectiva psicológica se cuenta con varios cuestionarios que permiten medir este trastorno; entre ellos, el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) destaca como uno de los primeros instrumentos validados en España y como uno de los más utilizados por investigadores y por diversos profesionales de la salud mental.

A partir de la tesis doctoral de Bermúdez y de las publicaciones que derivaron de ésta (Bermúdez, 1977, 1978a, 1978b), junto con la replicación de los datos por Urraca (1981) se realizó la primera edición del manual de la adaptación española del STAI (Departamento de I+D de TEA, 1982). Desde entonces, la consolidación del mismo ha sido un hecho. Actualmente, el conocimiento de esta prueba se inicia de forma habitual en el Grado de Psicología ya que, en muchas facultades, se enseña a aplicar, corregir e interpretar este cuestionario.

En el ámbito profesional, el STAI se sigue empleando frecuentemente y en muy diversos ámbitos, presentándose como el séptimo cuestionario más utilizado en España por psicólogos de diversas especialidades y campos (Muñiz y Fernández-Hermida, 2010). Todo ello, hace de este cuestionario una de las medidas clásicas para evaluar ansiedad en lengua castellana y lo convierte en un referente en la evaluación del constructo, siendo utilizado habitualmente para validar otros instrumentos afines.

Ahora, casi treinta años después de la primera edición española, los resultados de varias investigaciones aconsejaron realizar una completa revisión de sus propiedades psicométricas, culminando en esta nueva edición y adaptación. A partir de una muestra reciente de más de 1.500 casos se ha procedido a revisar todos los índices psicométricos contenidos en este manual, incluyendo baremos actualizados de adolescentes, universitarios y adultos que ven ampliadas y reforzadas su representatividad y vigencia. Esto permitirá que la prueba siga manteniendo su calidad a la hora de medir la ansiedad y que las nuevas evaluaciones que se realicen con él sean adecuadas y permitan comparar las puntuaciones de los sujetos con baremos realizados con muestras actuales.

Este proceso de la nueva edición y adaptación española del STAI no habría sido posible sin la ayuda de todos los profesionales y colaboradores que ayudaron a recoger las muestras de adolescentes y adultos. Igualmente damos las gracias a todos aquellos que nos asesoraron en el proceso y particularmente a los participantes que cumplieron la prueba. Asimismo, dar las gracias a todos los que hicieron posible la adaptación española original del cuestionario y participaron de alguna manera en su desarrollo y consolidación. A todos ellos, queremos darles las gracias por su ayuda, sin la que no hubiese sido posible este proyecto.

Gualberto Buela-Casal, Alejandro Guillén-Riquelme y Nicolás Seisdedos
Madrid, julio de 2011

1. Descripción general

1.1. Ficha técnica

Nombre: STAI, Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo.

Nombre original: “State-Trait Anxiety Inventory (Self Evaluation Questionnaire)”.

Autores: C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch y R. E. Lushene.

Procedencia: Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California.

Adaptación española: Gualberto Buena-Casal, Alejandro Guillén-Riquelme y Nicolás Seisdedos Cubero, 1982, 2011.

Aplicación: Individual o colectiva.

Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos, con un nivel cultural mínimo para comprender las instrucciones y enunciados del cuestionario.

Duración: Aproximadamente, unos 15 minutos.

Finalidad: Evaluación de la ansiedad como estado y como rasgo.

Baremación: Baremos percentiles y decatipos de adolescentes y adultos por sexo.

Material: Manual y ejemplar autocorregible.

1.2. Fundamentación y datos históricos

Una primera versión del Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) está descrita y evaluada en la obra de Levitt (1967); en un capítulo dedicado a la ansiedad, el autor compara y contrasta el STAI con otros instrumentos psicológicos desarrollados para medir esta variable.

El Cuestionario STAI comprende escalas separadas de autoevaluación que miden dos conceptos independientes de la ansiedad, como estado (E) y como rasgo (R). Aunque originalmente fue ideado como instrumento para investigar los fenómenos de la ansiedad en adultos “normales” (sin alteraciones psiquiátricas), el STAI ha mostrado ser útil para medir ambos conceptos tanto en escolares de estudios medios y superiores como en pacientes de diversos grupos clínicos.

La ansiedad Estado (A/E) está conceptualizada como un estado o condición emocional transitoria del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como por una hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Puede variar con el tiempo y fluctuar en intensidad.

La ansiedad Rasgo (A/R) señala una relativamente estable propensión ansiosa por la que difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras y a elevar, consecuentemente, su ansiedad Estado (A/E). Como un concepto psicológico, la A/R posee características similares a los constructos que Atkinson llama “motivos” (esas disposiciones que permanecen latentes hasta que son activadas por algunos estímulos de la situación), y que Campbell alude como “disposiciones comportamentales adquiridas” (residuos de experiencias pasadas que predisponen tanto a ver el mundo de una determinada manera como a manifestar unas tendencias de respuesta vinculada al objeto).

Ambos conceptos, en ciertos aspectos, se asemejan a las energías cinestésica y potencial en el mundo de la física. La primera es una manifestación, en un determinado momento y con un grado de intensidad, de un proceso o reacción empírica, mientras que la segunda indica diferencias de fuerza en una disposición latente para manifestar un determinado tipo de reacción. De la misma manera que la energía potencial presenta diferencias entre los objetos en la cantidad de energía cinestésica que puede ser liberada mediante la aplicación de una fuerza apropiada, la ansiedad rasgo implica diferencias entre los sujetos en su disposición para responder a situaciones tensas con diferentes cantidades de ansiedad estado.

En general, los sujetos A/R+ (con mayor ansiedad rasgo) presentarán un A/E + (mayor ansiedad estado) que los sujetos A/R-, porque los A/R+ ven muchas más situaciones amenazadoras. Por tanto, los A/R+ son más propensos a responder con un aumento de A/E en situaciones de relaciones interpersonales que impliquen alguna amenaza a la autoestima (por ejemplo, enfrentarse a una tarea difícil o novedosa). Sin embargo, el hecho de que las personas que difieren en A/R muestren unas correspondientes diferencias en A/E, depende del grado en que la situación específica es percibida por un determinado individuo como peligrosa o amenazadora, y esto está muy influido por las particulares experiencias pasadas.



Los conceptos de estado y rasgo que guiaron la construcción del STAI son tratados con detalle en la obra de Spielberger (1966a), y las circunstancias y condiciones que parecen evocar niveles altos de A/E en personas que difieren en A/R se analizan en el trabajo de Spielberger y colaboradores (1971).

1.3. Descripción de las escalas

La construcción del STAI comenzó en 1964, con la finalidad de desarrollar una única escala que permitiera medidas objetivas de autoevaluación de la ansiedad, tanto de estado como de rasgo. Durante el curso de los estudios, los resultados vinieron a introducir cambios en la concepción teórica de la ansiedad, y especialmente en lo que se refiere a la ansiedad rasgo; en consecuencia, se introdujeron modificaciones en el proceso de la construcción del STAI.

En principio, se dio por supuesto que los elementos que presentasen relaciones con otros instrumentos de medida de la ansiedad, serían útiles en un cuestionario diseñado para medir el estado y rasgo de la ansiedad. Como la mayoría de las escalas de ansiedad existentes medían el rasgo, se redactaron de nuevo muchos elementos, de modo que midieran tanto el estado como el rasgo; y el resultado fue un STAI único (Forma A) que, con diferentes instrucciones de aplicación, podía medir ambas variables.

Sin embargo, se observó que las características psicolingüísticas de algunos elementos de esa Forma A (sobre todo las palabras claves) presentaban significados que interferían cuando se las utilizaba como medidas de ambas variables. Más aún, muchos de los mejores elementos de ambas habían sido excluidos porque, incluso alterando las instrucciones de aplicación, no se soslayaban las fuertes connotaciones estado o rasgo de las palabras claves utilizadas. Por ejemplo, “Me canso rápidamente”, que parecía tener la connotación de un rasgo relativamente estable de la personalidad, presentó elevadas correlaciones con otros elementos de A/R y no mostraba los cambios esperados como medida de A/E en condiciones experimentales de tensión o relajación. Sin embargo, “Me siento alterado” resultó un buen elemento de A/E y deficiente en A/R.

Consecuentemente, se cambió la estrategia de selección de elementos para tomar aquellos que mejor midieran A/E y aquellos otros que discriminaran mejor A/R, y su resultado fue la Forma X (la utilizada para elaborar la versión española). Aunque todavía existen unos pocos elementos que miden bien ambas variables, la mayoría discrimina mejor una de ellas. En dicha Forma X existen cinco elementos con igual redacción en A/E y A/R (por lo menos en cuanto a la palabra clave). Las restantes 15 cuestiones de cada escala difieren suficientemente en cuanto a su contenido y sus connotaciones.

En las primeras fases de su construcción se utilizaron muestras de estudiantes universitarios no graduados (con más de 3.000 casos) que contestaron a la Forma A. En la siguiente fase se aplicó la Forma X a unos 3.300 alumnos de enseñanza secundaria y universitaria, y se complementaron con más de 600 pacientes de medicina y neuropsiquiatría y unos 200 reclusos de prisiones.

En el proceso original de su adaptación española, como se ha indicado anteriormente, se siguió un proceso de tipificación similar al original: obtención de muestras de estudiantes universitarios con una primera versión experimental (Bermúdez, 1978a, 1978b), replicación de los resultados obtenidos con nuevas muestras de estudiantes y de adultos normales y con una segunda versión experimental, y su contraste y validación con grupos clínicos (Urraca, 1981; Iglesias, 1982). En muestras de sujetos normales se alcanzó el millar de casos, lo cual permitió una buena fundamentación estadística de la versión española del STAI. La escala E (A/E) consta de 20 frases con las que el sujeto puede describir cómo se siente “en un momento particular, mientras que la escala R (A/R), también con 20 frases, puede mostrar cómo se siente el sujeto “generalmente”.

1.4. Justificación de la nueva edición y adaptación

Desde su adaptación española en 1982, el STAI ha mostrado ser un instrumento útil y eficaz para medir ansiedad en diversos ámbitos. Prueba de ello es que el cuestionario ha sido utilizado en más de 3.900 investigaciones hasta el año 2000 y que ha sido adaptado a más de 40 idiomas y países (Guillén-Riquelme y Bucla-Casal, en prensa). Durante los años transcurridos desde su creación se ha mostrado la utilidad del cuestionario a la hora de medir la ansiedad en varios contextos tales como adolescentes y adultos en diversos contextos.

Por otra parte, más allá de sus implicaciones en investigación, el STAI se ha establecido como una de las principales herramientas de los diversos profesionales de la salud mental a la hora de evaluar ansiedad. Así pues, en el estudio de Muñiz y Fernández-Hermida (2010) se realizó una encuesta a más de 3.000 psicólogos españoles colegiados, donde se observó que el STAI era el séptimo cuestionario más utilizado por los psicólogos en general y que también ocupaba esta misma posición entre los instrumentos más utilizados dentro de la Psicología Clínica.

Por todo lo visto anteriormente, se puede concluir que el STAI es un cuestionario que, pese a haber sido adaptado al castellano hace casi tres décadas, se sigue utilizando tanto para investigación como para la práctica clínica de la Psicología y otras profesiones afines. Sin embargo, en el estudio de Guillén-Riquelme y Bucla-Casal (en prensa), se halló que, en una nueva muestra española de población general, las puntuaciones medias de las escalas variaban respecto a los valores indicados en la adaptación original. Se observó que, para los diferentes grupos utilizados, la A/R variaba casi un punto y medio respecto a los datos de la adaptación original. Sin embargo, en el caso de la A/E, las diferencias eran de entre cinco y seis puntos por debajo de las puntuaciones que se presentaban en los baremos originales de su adaptación española. Esta diferencia entre las puntuaciones en A/E podría deberse a que las demandas ambientales y estímulares se han elevado con el paso del tiempo. Este hecho habría producido que los ítems que antes eran sinónimo de una elevada ansiedad hayan perdido sensibilidad, considerándose “normales” o cotidianos. Además, los resultados también indican que la A/R (teóricamente más estable) se ha mantenido prácticamente igual, pese al tiempo transcurrido desde la primera edición. Estos resultados



son un indicador de que el cuestionario sigue siendo válido, puesto que ha detectado cambios en la A/E sin modificarse apenas las medidas en la A/R.

Así, los estudios realizados con muestras más recientes han mostrado el posible sesgo de los baremos existentes previamente y la necesidad de acometer una completa actualización de sus baremos y una revisión de sus propiedades psicométricas, labor que se presenta en esta nueva edición del manual. Con este fin se han recogido más de 1.500 casos evaluados recientemente y se ha procedido a calcular los distintos índices estadísticos de la prueba (análisis de elementos, fiabilidad, estructura factorial) con el fin de actualizar el apartado de fundamentación estadística de esta obra. A pesar de actualizar los datos, se ha preferido mantener tanto la estructura general del manual como los índices y elecciones estadísticas de la anterior adaptación (en la medida que las indicaciones y novedades metodológicas lo permitan) para facilitar la labor del profesional habituado al manejo de la obra.

1.5. Finalidad y aplicaciones

Como se ha indicado anteriormente, la primera finalidad de la construcción del STAI fue la de disponer de un instrumento para investigar los fenómenos de la ansiedad (mediante una autoevaluación de dos conceptos independientes de la misma).

Así, la subescala A/E puede ser utilizada para determinar los niveles actuales de intensidad de la ansiedad inducidos por procedimientos experimentales cargados de tensión o “estrés”, o como un índice del nivel del impulso (“drive”, D), tal como fue definido por Hull (1943) y Spence (1958). Se ha observado que las puntuaciones A/E aumentan como respuesta a diferentes tipos de tensión y disminuyen como resultado de las técnicas de relajación.

Por otra parte, la variable A/R puede ser utilizada en la investigación para seleccionar sujetos con diferente predisposición a responder al “estrés” psicológico con distintos niveles de intensidad de la A/E.

El STAI también ha mostrado ser útil en una labor clínica. La puntuación A/R permite discriminar alumnos (enseñanza secundaria o universitaria) según su predisposición a la ansiedad, así como para evaluar el grado en que están afectados por problemas de ansiedad neurótica los alumnos que acuden a los servicios de orientación y consejo.

La puntuación A/E es un índice sensible del nivel de ansiedad transitoria de los sujetos o pacientes de orientación, psicoterapia, modificación de conducta u hospital psiquiátrico. También puede ser utilizada para medir los cambios que ocurren en éstas situaciones en la variable A/E. Las características esenciales evaluadas por A/E incluyen sentimientos de tensión, nerviosismo, preocupación y aprensión.

En el manual original se citan trabajos (capítulo III) en los que se ha utilizado el STAI en investigaciones tomando como sujetos alumnos de diferentes edades y niveles escolares, así como variadas poblaciones de pacientes o grupos clínicos.

1.6. Material

Aparte del presente manual (con las bases teóricas, descripción, normas de aplicación e interpretación y fundamentación estadística), es necesario el uso del ejemplar autocorregible que contiene los ítems y las instrucciones necesarias para llevar a cabo la corrección.

Es posible utilizar la mecanización en los procesos de corrección, puntuación e interpretación, pero exige la utilización de una hoja de respuestas de diseño especial y de lapicero y goma para su cumplimentación.

2. Normas de aplicación y corrección

2.1. Instrucciones para la aplicación

En principio, el STAI fue diseñado para una autoaplicación, y puede ser aplicado individual y colectivamente. Las instrucciones necesarias para cada una de las dos partes (A/E y A/R) están impresas en el ejemplar.

El cuestionario no tiene tiempo limitado, y los estudiantes universitarios emplean entre seis y ocho minutos para cada parte, es decir, aproximadamente un cuarto de hora para la aplicación completa del STAI; cuando es necesario repetir la parte A/E, sólo se necesitan unos cinco minutos.

Aunque algunos de los elementos del STAI tienen validez aparente como medida de la “ansiedad”, el examinador procurará no emplear este término; es preferible referirse al instrumento y sus partes como “cuestionario de autoevaluación”.

Su validez descansa en el supuesto de que el sujeto evaluado entiende claramente las instrucciones referidas al “estado” y refleja sus impresiones sobre lo que siente “en ese momento”, mientras que en la parte referida al “rasgo” anota lo que siente “en general”. Conviene subrayar éstas diferencias en las dos partes del STAI, y leer cuidadosamente sus respectivas instrucciones, aunque en principio parezcan casi iguales. Si el examinador las lee en voz alta mientras los sujetos lo hacen en silencio, se pueden resolver algunas dudas.

Cuando, durante el desarrollo del examen, surja alguna pregunta, el examinador puede contestarla de forma que no influya en el resto de la prueba ni en los demás examinandos. Casi siempre es suficiente contestar con un “simplemente intente contestar de acuerdo con lo que Vd. siente o piensa en este momento (o en general)”.

La mayoría de las personas contestan con prontitud a todas las frases del STAI, pero, en ocasiones, hay que decir o subrayar que es necesario contestar a todas ellas.

En la tipificación del STAI se ha aplicado siempre primero la parte A/E y luego la A/R, y se recomienda este orden. Como la medida A/E se ha diseñado para ser sensible a las condiciones o circunstancias que han aconsejado su uso, las puntuaciones en esta escala pueden verse afectadas por la atmósfera emocional creada si la parte A/R se aplicase

primero. Por otra parte, se ha demostrado que la puntuación A/R no se afecta por esas condiciones específicas en las que se aplica el STAI.

En las instrucciones de aplicación, el examinador pedirá a los sujetos que rodeen uno de los números 0 a 3 impresos en el ejemplar junto a de cada frase. Cuando el STAI se aplique con hoja de respuestas especial para su mecanización, no se harán anotaciones en el ejemplar y las respuestas se darán en la hoja; en éstas situaciones, el examinador adecuará sus instrucciones a éstas exigencias y las impuestas por el diseño específico de la hoja que va a corregirse mediante lectora óptica.

No deberían nunca modificarse las instrucciones impresas en la parte A/R; sin embargo, las referidas al A/E pueden alterarse para evaluar el nivel de intensidad “estado” en una determinada situación para un específico intervalo de tiempo de interés para el investigador o para el psicólogo clínico. Así, por ejemplo, para fines de investigación, el examinador puede enfocar su interés en un determinado período de tiempo: “lo que sentía cuando realizaba la tarea experimental X”, “al enfrentarse a la tarea X” o “al terminar la tarea X”, “durante la escena A”, “cuando tenía delante el estímulo S” (en el caso de terapia de conducta), etc. Para la mayoría de las personas no es difícil responder al STAI A/E de acuerdo con los sentimientos específicos en un momento determinado, siempre que estos sean recientes y el sujeto esté motivado para colaborar con el experimentador.

Para medir los cambios de “estado” después de un tiempo, se recomienda aplicar la parte A/E en cada ocasión crítica. Se ha observado que la repetición de los tests de personalidad aumenta su fiabilidad para discriminar entre los sujetos, o al menos no influye significativamente en las puntuaciones.

Cuando sea absolutamente necesario dentro de una investigación obtener medidas repetidas de A/E durante la realización de tareas experimentales, se pueden construir pequeñas escalas con cuatro o cinco elementos del STAI A/E de mayor validez, con lo cual se alteraría poco o nada la tarea experimental.

2.2. Obtención de las puntuaciones A/E y A/R

Las puntuaciones A/E y A/R pueden variar desde un mínimo de 0 puntos hasta un máximo de 60 puntos. Los sujetos mismos se evalúan en una escala que va de 0 a 3 puntos en cada elemento. En cada parte, las categorías son las siguientes:

STAI A/E	STAI A/R
0 Nada	0 Casi nunca
1 Algo	1 A veces
2 Bastante	2 A menudo
3 Mucho	3 Casi siempre



En la versión española del STAI se ha cambiado la escala 1-4 original por otra (0-3) en la que la negación de un sentimiento (nada o casi nunca, respectivamente) tuviera un valor de cero puntos en la apreciación del sujeto.

Algunos elementos (como “Estoy tenso”) se han redactado de forma que el punto 3 de la escala señala un elevado nivel de ansiedad, mientras que otros (como “Me siento seguro”) el mismo punto 3 indica un bajo nivel de ansiedad. En este sentido, para obtener la puntuación, el primer tipo de elementos se ponderan en el mismo sentido de la escala, mientras que en los segundos hay que invertir la escala (es decir, se conceden tres puntos si el sujeto marca el 0, dos puntos si señala el 1, un punto si el 2, y cero puntos si se da el 3).

En la elaboración del STAI se han entremezclado los elementos de ambos tipos (escala directa y escala inversa) para soslayar el efecto de aquiescencia en las respuestas del sujeto. En la parte A/E hay 10 elementos de escala directa y otros 10 de escala invertida, mientras que en la parte A/R, como no se disponía de suficiente número de elementos satisfactorios de escala invertida, solo se incluyeron 7 de éstos, y los 13 restantes son de escala directa. Los elementos de escala invertida en cada parte son los siguientes:

A/E: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20.
A/R: 21, 26, 27, 30, 33, 36 y 39.

Para evitar que el examinador tenga que hacer la inversión y recordar a cuáles elementos afecta esto, se ha construido el ejemplar autocorregible que facilita la tarea de la corrección y puntuación.

El ejemplar autocorregible del STAI está diseñado de manera que al cortar el trepado lateral y levantar la primera hoja, queda a la vista la copia de las respuestas marcadas por el sujeto y la puntuación correspondiente a cada respuesta, una vez invertidos los valores.

De esta forma, basta con sumar las cantidades que han quedado bajo los círculos en cada una de las partes, A/E y A/R, y trasladar esas sumas a los recuadros correspondientes para disponer de la puntuación directa.

Por último, la consulta de la tabla de baremos del manual permite la transformación de cada puntuación directa en puntuación percentil o decatipo, según se prefiera. Consulte el apartado 4.2 de este manual para más información sobre la interpretación de estas puntuaciones transformadas y el uso adecuado del baremo.

La mayoría de los sujetos responde al STAI dando una respuesta a todos los elementos sin necesidad de unas instrucciones específicas de tipo compulsivo. Si se dejan elementos en blanco, esto puede ser debido a inatención a las instrucciones o a incomprensión del contenido de los mismos elementos. Cuando se ha omitido uno o dos elementos, se puede prorratear la puntuación final de la siguiente manera: 1) calcular la media en los elementos contestados en esa parte (P. directa / núm. elem. contestados); 2) multiplicar el resultado por 20; 3) redondear el resultado al entero más próximo. Si el número de elementos omitidos en una de las partes E o R es tres o más, es conveniente poner en duda la validez de la aplicación realizada.

3. Fundamentación estadística

Este capítulo expone y recoge, de manera resumida, algunos resultados estadísticos obtenidos en los estudios originales (tomados del manual de Spielberger *et al.*, 1970), en los análisis realizados en la adaptación española original (Seisdedos, 1982) y en la investigación de Guillén-Riquelme y Buela-Casal (en prensa). Consúltase la bibliografía para un mayor detalle y especificación. Con ello se pretende justificar, expositiva y estadísticamente, aquellos índices que permitan una utilización práctica más sensata y científica del STAI.

3.1. Estudios originales ⁽¹⁾

En los estudios y tipificación se utilizaron muestras amplias de alumnos de enseñanza secundaria (grupo A) y universitaria (grupos B y C), de pacientes de neuropsiquiatría (NP) y de medicina general y cirugía (MGC), así como de jóvenes reclusos en cárceles (JRC). La tabla 1 presenta los casos (N), medias (Media) y desviaciones típicas (Dt) de los citados grupos de sujetos normales (en los que se obtuvieron también los coeficientes “alfa”) y de tipo clínico.

⁽¹⁾ Cuando el psicólogo español compare sus resultados con los originales, debe recordar que en la versión española del STAI se ha cambiado la escala de respuestas (se ha reducido a 0-3 la original 1-4). Esto afecta únicamente a los promedios (medias), que se ven reducidos en 20 puntos; es decir, un valor original de 46 puntos tiene la misma consideración que un dato español de 26 puntos. Este cambio de escala no ha afectado a los demás estadísticos (desviación típica, índices fiabilidad y correlación, etc.) y su comparación puede hacerse directamente.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de muestras originales

Grupo	N	Estado			Rasgo		
		Media	Dt	Alfa	Media	Dt	Alfa
A - Varones	190	36,99	9,07	0,86	39,37	9,40	0,89
A - Mujeres	187	37,57	11,76	0,92	41,61	11,29	0,92
B - Varones	334	40,01	7,85	0,83	38,07	8,20	0,86
B - Mujeres	648	39,39	8,62	0,86	38,22	8,20	0,86
C - Varones	253	36,35	9,67	0,89	37,68	9,69	0,90
C - Mujeres	231	35,12	9,25	0,89	38,25	9,14	0,89
Total pacientes NP	461	47,74	13,24		46,62	12,41	
Reacción depresiva	28	54,43	13,02		53,43	12,91	
Reacción de ansiedad	60	49,02	11,62		48,08	10,65	
Esquizofrenia	161	45,70	13,44		45,72	12,37	
Lesión cerebral	31	46,94	13,41		44,64	11,20	
Alteración de carácter	22	40,54	14,27		40,32	13,06	
Total casos MGC	161	42,38	13,79		41,91	12,70	
Con complicación psiquiátrica	34	42,35	15,66		44,62	14,12	
Sin complicación psiquiátrica	110	42,68	13,76		41,33	12,55	
Jóvenes en cárceles	212	45,96	11,04		44,64	10,47	

Estos resultados originales muestran que, aunque en el grupo A (alumnos de enseñanza secundaria), las puntuaciones son algo mayores en las mujeres, entre los universitarios ambos sexos obtienen puntuaciones similares. En los grupos B y C se observó el efecto de la situación de tensión del examen (en el caso del grupo B el STAI fue aplicado en un proceso selectivo de ingreso a los estudios universitarios).

En los grupos clínicos, la edad media de los sujetos NP era de 43 años, 55 años en los casos MGC, y 21 años en los internos en prisiones. Aunque la edad y el nivel de formación parece no tener correlación significativa con las puntuaciones de ansiedad, se encontró una relación inversa ($r = -0,22$) con el nivel de formación y la puntuación A/R en casos MGC; algo parecido se puede observar en un análisis de los promedios de los grupos A, B y C.

Los coeficientes "alfa" son una medida de la consistencia interna; se obtuvieron mediante la fórmula KR-20 modificada por Cronbach, y los índices hallados en muestras de sujetos normales son bastante buenos (entre 0,83 y 0,92).

Otro tipo de fiabilidad (Tabla 2) fue obtenido, en subgrupos de sujetos normales, mediante el procedimiento test-retest con diferentes intervalos de tiempo: 1 hora, 20 días



y 104 días. En el primer caso, los alumnos que realizaron el retest, durante la hora de intervalo fueron expuestos a las siguientes condiciones experimentales: breve período de relajación, examen con un test difícil de inteligencia y exposición de una película de accidentes con heridos y muertos. Esto hizo que, aunque la fiabilidad en el A/R era relativamente buena, la fiabilidad A/E se vio muy afectada por los factores situacionales introducidos durante la hora de intervalo. Naturalmente, los mejores índices se obtienen en el A/R.

Tabla 2. Fiabilidad test-retest en alumnos universitarios

Grupo	1 hora		20 días		104 días	
	N	r	N	r	N	r
A/E Varones	88	0,33	38	0,54	25	0,33
A/E Mujeres	109	0,16	75	0,27	22	0,31
A/R Varones	88	0,84	38	0,86	25	0,73
A/R Mujeres	109	0,76	75	0,76	22	0,77

La validez de criterio del STAI fue tenida en cuenta en el proceso de construcción y selección de los elementos. En la tabla 3 se ofrecen algunos resultados de la validez concurrente, obtenidos originalmente; se pusieron en relación el STAI A/R, la Escala de Ansiedad de Cattell y colaboradores (IPAT), la Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor (TMAS) y el Inventario de Adjetivos de Afectos de Zuckerman (AACL), en dos grupos de estudiantes universitarios (varones y mujeres y otro de pacientes neuropsiquiátricos (NP). Como las intercorrelaciones entre STAI, IPAT y TMAS son elevadas y se acercan a sus índices de fiabilidad, puede concluirse que los tres son medidas alternativas de la ansiedad, mientras que el AACL correlaciona solo moderadamente con las citadas medidas de la ansiedad.

Tabla 3. Correlaciones entre el STAI A/R y otras medidas de ansiedad

Grupo	80 V Universitarios			126 V Universitarios			66 casos NP		
	STAI A/R	IPAT	TMAS	STAI A/R	IPAT	TMAS	STAI A/R	IPAT	TMAS
IPAT	0,76			0,75			0,77*		
TMS	0,79	0,73		0,80	0,85		0,83	0,84	
AACL	0,58	0,51	0,41	0,52	0,57	0,53			

* n = 112 para la correlación entre el STAI A/R y el IPAT.

Una evidencia de la validez de constructo de A/E fue determinada analizando las diferencias entre los resultados en situaciones normales y suponiendo la inminencia de un examen entre alumnos universitarios (332 varones y 645 mujeres); no sólo la puntuación final A/E, sino también todos los elementos (excepto el núm. 8) mostraban diferencias significativas a un nivel de confianza del 1 por 100.

Cuando se han puesto en relación los resultados del STAI con otras pruebas de personalidad, se han encontrado índices positivos significativos entre el A/R (que son valores más importantes que los A/E al ponerlos en relación con las medidas de la personalidad) y la Agresión y la Impulsividad, y negativos con la Dureza, Afiliación, Dominancia, Cuidado y Orden; pero esta información puede resultar imprecisa si no se tiene en cuenta el instrumento de personalidad utilizado. Por éstas razones, y dado que en los estudios originales se citan cuestionarios de personalidad desconocidos en el ambiente psicológico español, tal vez sea más ilustrativo reflejar los índices encontrados utilizando un instrumento más universalmente conocido, el MMPI. En este estudio se utilizaron dos muestras de pacientes varones, veteranos de guerra, hospitalizados como casos neuropsiquiátricos (NP); además de los estadísticos obtenidos con el MMPI la tabla 4 presenta también los encontrados con el "Cornell Medical Index" y el test Beta de inteligencia.

Los resultados de la ansiedad rasgo presentados en la tabla 4 son bastante comparables en ambas muestras de pacientes neuropsiquiátricos; en cuanto a la ansiedad estado, se observa una mayor correlación en la primera muestra, que es, naturalmente, la que tiene mayores elevaciones en las escalas clínicas del MMPI (lo cual señala la sensibilidad del STAI para mostrar esas diferencias), sobre todo en las escalas D, Pt y Sc (Depresión, Psicastenia y Esquizofrenia) del MMPI. Por otra parte, el hecho de la elevada relación con el Cornell viene a mostrar que tanto el A/E como el A/R están asociados con un gran número de síntomas médicos. Finalmente, la inexistencia de relación del STAI con la medida de la inteligencia corrobora otros hallazgos en los estudios originales no citados en este manual para aligerar su texto.

Por estas mismas razones no se van a incluir y detallar otras investigaciones en las que el STAI ha sido un instrumento importante. A lo largo de las cuatro décadas transcurridas desde su creación original ha sido utilizado en numerosos y variados estudios, con muestras tales como:

- Estudiantes: retest después de tensión (fracaso escolar o shock), estudio de la tensión después de los exámenes, análisis de A/E junto a tests de figuras o formas enmascaradas, introspección personal de la ansiedad, análisis del temor y alteraciones psicosomáticas frente al hablar en público, relación con información y retroinformación en tareas intelectuales (inteligencia, memoria o aprendizajes diversos), etc.
- Grupos clínicos: ansiedad en casos de esquizofrenia con diferente entrevista de contacto, factores emocionales/actitudinales en embarazo normal o complicado, información preterapéutica y modificación de conducta, etc.

El lector puede acudir a las fuentes bibliográficas para encontrar el desarrollo y resultados de estos estudios.

**Tabla 4.** Correlaciones del STAI A/R y A/E con otras pruebas

MMPI	129 casos NP				79 casos NP			
	Media	Dt	r_{xy}		Media	Dt	r_{xy}	
			A/E	A/R			A/E	A/R
L	4,43	2,90	-0,52	-0,49	4,75	2,51	-0,34	-0,25
F	10,90	7,14	0,56	0,60	10,06	8,44	0,34	0,61
K	11,77	5,65	-0,64	-0,63	13,76	5,33	-0,46	-0,60
Hs	16,32	7,44	0,57	0,60	14,30	7,91	0,40	0,49
D	30,44	7,07	0,57	0,57	27,58	6,87	0,44	0,61
Hy	28,71	6,90	0,26	0,26	27,34	6,72	0,23	0,21
Pd	22,90	5,55	0,52	0,49	21,48	6,08	0,48	0,60
Mf	24,44	4,75	0,20	0,28	23,15	4,52	0,16	0,25
Pa	13,24	5,11	0,50	0,53	12,26	5,18	0,24	0,50
Pt	23,52	10,97	0,79	0,81	17,92	11,25	0,45	0,65
Sc	24,01	13,60	0,71	0,75	19,53	14,67	0,46	0,68
Ma	19,38	5,36	0,30	0,31	18,57	5,23	0,33	0,48
Cornell	33,74	19,46	0,70	0,70				
Beta	96,37	9,48	-0,08	-0,03				

3.2. Adaptación española: fiabilidad y validez

Tal vez el primer antecedente de la adaptación española del STAI sea el estudio de Bermúdez (1977) con su Tesis doctoral; este trabajo empleó una versión experimental del STAI para utilizar las escalas Estado y Rasgo como variables moduladoras en el estudio de rendimiento de los sujetos en una tarea fácil (test perceptivo) y otra difícil (test de inteligencia). Se utilizó una muestra de más de 500 casos a los que se les aplicó el STAI con unos elementos muy similares a lo que ahora se ofrecen como versión definitiva (excepto que en el elemento 34 se invirtió el sentido: “Trato de...”, en vez de “Evito...” que ahora tiene). Por otra parte, en estos análisis se utilizó la escala original de 1 a 4 puntos en cada elemento, y de ahí que a sus puntuaciones directas sea necesario restarle 20 puntos para poder compararlas con las obtenidas en la tipificación y análisis que vienen en los párrafos siguientes; cuando se hace esta diferencia se observa que sus promedios en Estado (16,81) y Rasgo (18,15) son comparables a los de la tipificación.

En los análisis factoriales que realiza Bermúdez (1977) con sus datos obtuvo como resultado cuatro dimensiones. Esta estructura es muy similar a la que se halló en la adaptación original del cuestionario y a la que se obtiene con los datos actuales.

Un segundo antecedente de esta adaptación española es otra tesis doctoral (Urraca, 1981), en la que, mediante las aplicaciones de varios cuestionarios (entre ellos el STAI, versión de Bermúdez, 1977), se han estudiado las actitudes ante la muerte. La muestra era más amplia que la anterior ($N = 1.282$) y diversa (estudiantes universitarios de varias facultades, trabajadores y enfermos). No se ha podido disponer de las puntuaciones directas de este estudio para su comparación con las de la versión definitiva, y en los análisis factoriales de Urraca solo se introducen los 20 elementos de cada escala, es decir, se independiza Estado de Rasgo a la hora de conocer su estructura factorial. Sin embargo, los elementos de cada escala se agrupan de modo muy similar a como resultan en los análisis de Bermúdez (1977) en los de su primera adaptación (Seisdedos, 1982) y en los actuales de esta edición; se encuentran dos factores en cada escala, de tipo afirmativo y negativo de la ansiedad (transitoria o permanente). En este trabajo, la ansiedad se presenta como una variable concomitante en las actitudes ante la muerte. Tal vez habría sido interesante o instructivo conocer los valores promedios del STAI A/R en los diversos subgrupos que pueden formarse en la amplia muestra de Urraca (por edad, sexo, estado de salud, etc.); habría sido ilustrativo de las manifestaciones y estructura de la ansiedad en muestras españolas.

A partir de los trabajos anteriores y la citada versión experimental de Bermúdez, se retocó la redacción de los elementos del STAI y se preparó una edición expresamente destinada a los estudios y tipificación. Se han obtenido más de mil aplicaciones de las mismas y clasificadas de varios modos han sido utilizadas en los análisis que se describen a continuación. Estos datos serán complementados con los obtenidos en el estudio de Guillén-Riquelme y Bucla-Casal (en prensa), que cuenta con una muestra superior a mil participantes. Además se incluyen los resultados de otras muestras recogidas por dichos autores.

A) Elementos y escalas: fiabilidad y valor discriminativo

Como se ha indicado anteriormente, existen 20 elementos en cada escala (Estado y Rasgo), que son puntuados en 0-3 según su carga y dirección hacia la ansiedad; existen 10 elementos en A/E y 13 en A/R que son afirmativos de ansiedad y 10 y 7, respectivamente en A/E y A/R, negativos de la misma. En la tabla los negativos de ansiedad vienen señalados con un asterisco después de su número de orden. En esta tabla 5 se presentan los resultados de varios análisis de elementos; en la mitad izquierda de la tabla se encuentran los elementos de A/E y en la mitad derecha los de A/R.

Estos análisis se refieren a cuatro muestras nuevas incluidas en la nueva edición y adaptación: A (1.157 varones y mujeres, mayores de edad, sin problemas clínicos y que no estuviesen cursando carrera universitaria, en el momento de la evaluación), B (541 jóvenes de ambos sexos desde 11 a 19 años que cursaban desde 1º de la E.S.O. hasta 2º de bachillerato), C (614 universitarios de diversas carreras) y D (266 pacientes clínicos cuyo diagnóstico principal era de depresión). En cada uno de los ítems se presenta las medias obtenidas por cada grupo, recordando que la escala de repuesta abarca desde 0 hasta 3 puntos.

Una observación detallada de la tabla 5 mostrará que, en general, la muestra clínica de depresivos obtiene mayores promedios en todos los ítems para ambas escalas (ya que



los ítems negativos han sido invertidos para realizar los resultados). En los análisis por edades se puede observar que existen ítems que muestran diferencias en función de los grupos de edad. Como se analizará más adelante, también hay notables variaciones por sexo, por lo que se recomendó una tipificación independiente de varones y mujeres en ambos grupos de edad (adolescentes y adultos).

Tabla 5. Análisis de ítems para varias muestras (normales y clínicas), medias de las escalas y fiabilidad (datos de la nueva edición y adaptación)

Ansiedad Estado					Ansiedad Estado				
Ítem	A	B	C	D	Ítem	A	B	C	D
1*	1,07	1,33	1,11	1,70	21*	0,87	1,54	0,95	1,78
2*	1,07	1,31	1,11	1,92	22	0,78	0,90	0,94	1,49
3	0,64	0,67	0,71	1,27	23	0,68	0,82	0,82	1,44
4	0,55	0,60	0,64	1,16	24	1,02	1,21	1,00	1,85
5*	1,03	1,25	1,25	1,92	25	0,96	1,10	1,08	1,37
6	0,52	0,61	0,55	1,11	26*	1,46	1,52	1,35	2,18
7	0,92	1,03	0,89	1,41	27*	1,42	1,65	1,44	1,93
8*	1,34	1,46	1,46	1,97	28	0,81	1,09	0,85	1,69
9	0,44	0,54	0,56	1,29	29	1,28	1,35	1,28	1,93
10*	1,22	1,44	1,24	1,91	30*	0,81	1,00	0,89	1,83
11*	1,07	1,33	1,19	1,95	31	1,74	1,45	1,58	2,17
12	0,71	0,91	0,81	1,37	32	1,13	1,13	1,24	2,00
13	0,72	0,73	0,86	1,24	33*	1,28	1,52	1,30	2,09
14	0,50	0,63	0,63	1,38	34	0,91	1,14	0,73	1,54
15*	1,26	1,39	1,43	2,05	35	0,78	0,83	0,78	1,69
16*	1,14	1,31	1,34	2,07	36*	1,10	1,30	1,23	2,02
17	0,90	1,02	1,04	1,68	37	1,08	1,21	1,05	1,73
18	0,42	0,65	0,39	1,03	38	1,26	1,27	1,22	1,90
19*	1,12	1,19	1,28	2,11	39*	0,92	1,32	1,16	1,79
20*	0,91	1,12	1,02	1,79	40	1,32	1,26	1,17	2,00
Media	17,48	20,74	19,45	31,98	Media	21,62	24,74	21,20	36,58
Dt	10,78	10,43	11,35	14,53	Dt	10,39	8,97	10,32	11,82
Alfa	0,93	0,89	0,92	0,95	Alfa	0,89	0,82	0,89	0,91
Edad	18-69	11-19	16-54	13-63	Edad	18-69	11-19	16-54	13-63

Nota: Los ítems con * han sido invertidos; Dt = desviación típica; Alfa = alfa de Cronbach.

En la base de la tabla se encuentran algunos estadísticos de los grupos: media aritmética (Media) en Estado y Rasgo, su desviación típica (Dt), el coeficiente alfa de Cronbach (alfa) de consistencia interna y el rango de edad para cada uno de los grupos.

En resumen, parece que los elementos del STAI son suficientemente discriminadores y diferenciadores (en variables tan fundamentales como la edad, el sexo y, naturalmente, en la que el instrumento intenta medir: la ansiedad) y poseen una buena consistencia interna (entre 0,89 y 0,95 en la A/E y entre 0,82 y 0,91 en A/R). En la muestra más amplia y heterogénea ($n = 1.157$) se calculó también la fiabilidad por el procedimiento de las dos mitades (los ítems del 1 al 10 y los del 11 al 20 para ambas subescalas) y los coeficientes obtenidos son similares a los anteriores: 0,94 en A/E y 0,89 en A/R.

Conviene recordar que estos índices de fiabilidad se refieren a la consistencia interna del instrumento; se asemejan a los obtenidos en estudios originales (véase la tabla 1, en el apartado anterior). Estos elevados índices de fiabilidad solo se mantienen en la variable Rasgo cuando se han realizado análisis de test-retest (en estudios originales, en tabla 2), mientras que la fiabilidad de A/E se ve muy afectada por la situación cuando se intenta una aplicación retest. Por otra parte, parece ser que la consistencia interna del A/E es más elevada en condiciones experimentales o situaciones en las que existe un mayor grado de estado de ansiedad.

B) Validez e intercorrelaciones del STAI

En cuanto que el STAI intenta medir el estado y rasgo de la ansiedad, la validez de sus elementos y escalas está íntimamente relacionada con los constructos previamente definidos y la construcción del instrumento; en esas fases previas se fueron eligiendo aquellos elementos que mejor validez de criterio tuvieran.

En la tabla 3 se han incluido algunos índices de validez concurrente obtenidos en los estudios originales; en una de las fases de la adaptación española se pudieron obtener índices de ese tipo aplicando junto al STAI un instrumento que evalúa ansiedad y desajuste de la personalidad a nivel de factor de segundo orden, el cuestionario de personalidad 16 PF Forma A de R. B. Cattell. Se utilizaron dos muestras (311 varones y 266 mujeres) de adultos profesionales⁽²⁾ que pasaron a formar parte de la muestra de tipificación; los varones obtuvieron en A/E y A/R unas medias de 19,34 y 19,50, mientras que en las mujeres sus respectivos promedios fueron de 19,99 y 22,38. En los análisis se mantuvieron separados ambos sexos y, además de las 16 escalas primarias (A a Q4) del Cuestionario, se utiliza la escala de Distorsión motivacional (DM) incorporada en el mismo; en cada sujeto se calculó el factor Ansiedad de segundo orden mediante la fórmula de ponderación de los decatipos en las escalas primarias (fórmula definida en la adaptación española del 16 PF, Seisdedos, 1981). Los resultados del estudio de correlación vienen expresados en centésimas (sin cero ni coma decimales) en la tabla 6.

(2) Los datos fueron cedidos por R. Tarilonte Díaz; formaban parte de su estudio sobre la ansiedad y el paro profesional. Agradecemos su colaboración.



Tabla 6. Correlaciones entre el STAI A/R y A/E con las escalas del 16 PF Forma A

Escala	Sexo	DM	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q1	Q2	Q3	Q4	Ans.
A/E	V	-14	-06	-27	-38	-13	-12	02	-16	-04	21	-05	29	36	-17	09	-10	20	44
A/E	M	-19	-15	-09	-30	-18	-14	-08	-10	09	10	-08	22	25	-04	11	-24	17	32
A/R	V	-28	-22	-15	-55	-26	-21	-09	-34	04	25	-12	31	48	-16	19	-30	40	55
A/R	M	-22	-14	-12	-54	-16	-16	-09	-26	-02	20	-23	28	48	-09	09	-37	40	58

En estos análisis la ansiedad estado parece estar relacionada con una personalidad inestable (C-), sumisa (E-), sobria (F-), calculadora (N+), aprensiva (O+) y frustrada (Q4+), y de ahí que resulte muy significativa la correlación de A/E con el factor Ansiedad de segundo orden. Es de destacar que los sujetos distorsionadores (DM) tienden a ocultar este tipo de ansiedad en una situación profesional. En esta muestra, solo en los varones se observa alguna relación (0,12) entre A/E y la edad.

En cuanto a la ansiedad rasgo (que en esta escala solo en las mujeres tiene alguna relación con la edad, -0,14), se repite el esquema de personalidad anterior: sujetos inestables, sumisos, sobrios, calculadores, aprensivos y frustrados, pero en mayor grado que en A/E; el resumen de Ansiedad que significa el factor de segundo orden presenta una relación altamente significativa (entre 0,55 y 0,58), mayor que en el caso de A/E, lo cual parece indicar que la medida de la ansiedad que supone el cuestionario factorial de Cattell es más de rasgo que de estado.

En parte de estas dos muestras se obtuvo también una medida de la Inteligencia (mediante un test ómnibus de tipo Otis), pero sus relaciones con el STAI no mostraron una tendencia clara, como tampoco la encontró el estudio experimental de Bermúdez (1977) ni fue hallada en los análisis originales americanos con variables de inteligencia y rendimiento escolar.

En un análisis sobre estudiantes universitarios, B. Sandín (1981) puso en relación el STAI con el cuestionario 8SQ ("Eight State Questionnaire" IPAT, 1971), pues en éste una de sus escalas es la Ansiedad; sometió una muestra de 83 sujetos (50 varones y 23 mujeres) a ambos instrumentos en dos momentos: 1) situación normal, 2) condiciones de tensión (descarga eléctrica en la mano). La medida de Ansiedad del 8SQ correlaciona con el A/E en un grado elevado (0,88 y 0,82, respectivamente, en los dos momentos), y esta relación se redujo mucho en el A/R (0,29 y 0,26, respectivamente). Aunque hay un ligero descenso en la situación experimental, parece que ésta no afecta en gran medida a las intercorrelaciones de las variables.

Finalmente, en casi todas las muestras de los análisis españoles citados se ha estudiado la intercorrelación de las dos escalas del STAI. Como han señalado los autores, el grado de esta relación depende del nivel de tensión existente cuando se aplique el A/E; en condiciones normales de aplicación y en muestras de mujeres se han encontrado índices que varían entre 0,44 y 0,55, mientras que entre los varones se ha encontrado

índices que van de 0,51 a 0,57; esta elevación entre los varones parece mostrar que cuando éstos presentan un elevado grado de A/R suelen tener también un elevado A/E con mayor frecuencia que las mujeres. En las muestras españolas se han observado los siguientes datos:

- a) 0,37 y 0,36 en los dos momentos del estudio de B. Sandín (1981).
- b) 0,43 como promedio en los análisis de J. Bermúdez (1978a).
- c) 0,72 en 1.157 personas de la muestra general de la nueva edición y adaptación.
- d) 0,68 en una muestra de 541 adolescentes escolarizados de ambos sexos de la nueva edición y adaptación.
- e) 0,75 en 614 universitarios de varias titulaciones de la nueva edición y adaptación.
- f) 0,70 en pacientes diagnosticados de depresión de la nueva edición y adaptación.

Así pues, en la muestra de tipificación española se ha observado también que entre los varones (sean adolescentes o adultos) existe una mayor interrelación entre A/E y A/R que entre las mujeres.

C) Análisis factoriales

Los primeros análisis factoriales en la adaptación española fueron realizados por J. Bermúdez (1978b) con la versión experimental. En el estudio se incluyeron los 40 elementos del STAI y se obtuvieron cuatro dimensiones que, en los distintos análisis, explicaban entre el 61 % y el 68 % de la varianza común.

En el trabajo de Urraca (1981) se introdujeron separadamente los 20 elementos de cada escala del STAI, y en cada grupo se hallaron dos dimensiones, similares a las de Bermúdez.

Utilizando la versión definitiva del STAI se replicaron estos resultados en diferentes muestras (casos normales y clínicos) de la adaptación original española (Seisdedos, 1982), tanto con soluciones ortogonales (Varimax) como oblicuas (Direct Quartimin). Se obtuvieron cuatro dimensiones, similares a las de Bermúdez (1978); atendiendo a las saturaciones más significativas en los elementos, se podrían definir por la escala y dirección o signo de la siguiente manera:

- *Factor I:* Ansiedad Estado Afirmativo (nerviosismo, tensión, preocupación e intranquilidad).
- *Factor II:* Ansiedad Estado Negativo (activación positiva, animación, bienestar, satisfacción y confianza en sí mismo).
- *Factor III:* Ansiedad Rasgo Afirmativo (melancolía, desesperanza y sentimientos de incapacidad).
- *Factor IV:* Ansiedad Rasgo Negativo (estabilidad y ausencia de cambios de humor).



Tabla 7. Saturaciones factoriales de los 40 elementos del STAI (se han señalado con un signo negativo los que niegan ansiedad) en las cuatro dimensiones (*)

Elemento	I	II	III	IV	h^2
-1		-358	212	369	41
-2			347	321	39
3		629			43
4		369			17
-5	204	-259	501		38
6		544			30
7		443			31
-8		-236	391	211	33
9		398		204	26
-10			504		30
-11	-261		261	272	30
12		605			41
13		366			17
14	229	256			28
-15		-346	282	274	37
-16			436		24
17		503			34
18		542			33
-19			623		42
-20		-311	642		63
-21	-517		441		53
22	348				14
23	468				27
24	334			222	19
25	414			-207	23
-26	-277		317		24
-27	-222			312	21
28	432	233			30
29	473				30
-30	-412		438		41
31				303	09
32	482				27
-33	-491		266		44
34					06
35	525				31
-36	-327		343		26
37	438				27
38	499				31
-39	-421			425	44
40	343	238			25
VT%	8,34	7,96	7,04	3,08	12,29
VC%	32,60	29,70	26,24	11,47	-

(*) Los valores h^2 representan el cuadrado de las correlaciones múltiples (covarianzas) de cada elemento con los factores, y en la base de la tabla se encuentra su suma total. Por la cuantía de éstas comunalidades puede observarse que en algunos elementos todavía queda mucha varianza sin explicar por estos cuatro factores.

Nota: Se han eliminado las saturaciones factoriales inferiores a 0.20.

Al lado del título, se han incluido entre paréntesis los conceptos descriptivos utilizados por Bermúdez (1978b). Probablemente, en realidad, la bipartición de cada escala (Estado o Rasgo) en dos dimensiones (afirmativa y negativa de ese tipo de ansiedad) pueda entenderse como un artefacto estadístico en cuanto que la agrupación de los elementos en cada dimensión sea debida al signo o dirección en que están redactadas las frases: afirmación de una conducta ansiosa o afirmación de una conducta positiva, estable o satisfactoria (lo cual en el STAI es una escala invertida de ansiedad).

Conviene recordar aquí lo indicado anteriormente; en la construcción del STAI y para balancear equilibradamente su presentación se introdujeron 10 elementos positivos y 10 negativos de ansiedad en el A/E, 13 positivos y 7 negativos en el A/R. Ha sido ésta la agrupación fundamental que han mostrado los análisis factoriales, con una estructura casi unánime en las distintas muestras. La tabla 7 presenta, en milésimas, las saturaciones superiores a 0,20 de los 40 elementos del STAI en las cuatro dimensiones en una muestra general de 1.109 sujetos, con una solución oblicua de factores principales [así como las comunales (h^2) en centésimas, de los elementos en estos factores]; en la base se indica el porcentaje de varianza total (VT) y varianza común (VC) que explica cada dimensión. En este estudio, para no desaprovechar aquellos sujetos que en uno o dos elementos no habían dado una respuesta (los habían dejado en blanco), se les adjudicó una puntuación intermedia (ni afirmativa ni negativa de ansiedad) en la escala de 0-3 puntos que tiene cada elemento, es decir, se les concedió 1,50 puntos en el elemento.

Con los datos actuales recogidos para la nueva edición y adaptación se replicaron estos análisis, obteniendo de nuevo las cuatro dimensiones comentadas anteriormente, aunque cabe indicar que los resultados no fueron tan claros como los obtenidos en estudios previos, quizás por variaciones en el procedimiento de ejecución del análisis factorial. La tabla 8 presenta las saturaciones, superiores a 0,30, de los 40 elementos del STAI en las cuatro dimensiones, en la muestra general de 1.157 sujetos, con una solución oblicua de máxima verosimilitud, así como las comunales (h^2) de los ítems en estos factores. Por otra parte, también se indica el porcentaje de varianza total (VT) que explica cada dimensión, siendo un 47,46% el total de la varianza explicada por los cuatro factores de forma conjunta.



Tabla 8. Saturaciones factoriales de los ítems del STAI en muestra general (datos de la nueva edición y adaptación)

Ítem	I	II	III	IV	h ²
1*	0,63		0,39		0,57
2*	0,75			0,36	0,73
3	0,37		0,66		0,65
4	0,38		0,50		0,48
5*	0,73				0,59
6	0,35		0,71		0,70
7		0,39			0,33
8*	0,56				0,36
9	0,40	0,36	0,50		0,55
10*	0,69				0,49
11*	0,64			0,43	0,66
12	0,31	0,31	0,67		0,65
13					0,13
14	0,33	0,36	0,40		0,41
15*	0,67		0,34		0,57
16*	0,78				0,62
17	0,43	0,39	0,46		0,56
18	0,31	0,31	0,61		0,56
19*	0,78				0,63
20*	0,79				0,64
21*	0,72				0,56
22		0,33			0,19
23		0,53			0,39
24	0,31	0,47			0,32
25		0,46			0,25
26*	0,47				0,25
27*	0,36				0,18
28	0,35	0,52			0,42
29		0,66			0,49
30*	0,73				0,57
31		0,47			0,23
32	0,35	0,60		0,35	0,60
33*	0,55	0,38		0,44	0,64
34		0,36			0,16
35	0,40	0,56			0,49
36*	0,73				0,59
37		0,62			0,44
38		0,62			0,42
39*	0,54				0,37
40		0,57			0,41
VT%	24,26	13,91	5,18	4,11	

Nota: Extracción mediante Máxima verosimilitud con rotación Quartimin. Los ítems con * están invertidos.
h² = comunalidades; VT % = varianza total explicada por cada factor.

Finalmente, para conocer las implicaciones de estas cuatro dimensiones en las variables edad y sexo, se diferenciaron unos ítems de otros mediante sombreados (en la copia del autocorregible) para permitir el cálculo de las puntuaciones afirmativas y negativas de ansiedad en A/E y A/R: EA (estado afirmativo), EN (estado negativo), RA (rasgo afirmativo) y RN (rasgo negativo). En la tabla 9 se ofrecen los estadísticos obtenidos por los varones y mujeres, adolescentes y adultos de la tipificación de la nueva edición y adaptación.

Tabla 9. Estadísticos en la afirmación/negación del Estado/Rasgo dentro del STAI (muestra de tipificación)

Escala		Varones		Mujeres	
		Adolescentes	Adultos	Adolescentes	Adultos
EA	N	216	416	292	651
	Media	7,08	5,68	7,61	6,72
	Dt	5,45	5,33	6,09	6,08
EN	N	223	434	298	673
	Media	12,84	10,53	13,49	11,69
	Dt	7,5	6,2	6,77	6,39
RA	N	219	445	298	692
	Media	12,83	11,8	16,23	15,03
	Dt	6,86	7,12	6,87	7,15
RN	N	225	444	302	690
	Media	9,62	7,17	10,11	8,34
	Dt	4,53	4,41	3,85	4,35

Nota: EA = Ansiedad estados afirmativa; EN = Ansiedad Estado Negativa; RA = Ansiedad rasgo afirmativa; RN = Ansiedad Rasgo Negativa; N = muestra; Dt = desviación típica. Se calcularon estos valores a partir de la puntuación ya invertida que aparece en la página de corrección del autocorregible.

La observación y análisis estadístico de las diferencias que presenta la tabla 9 son coherentes con los obtenidos en su adaptación original (Seisdedos, 1982) y permiten extraer similares consideraciones:

- Aunque ambas subescalas de Estado (EA y EN), tienen igual número de elementos, ambos sexos obtienen una puntuación superior en EN. Es decir, las muestras normales no suelen tanto afirmar la ansiedad (EA; esto es responder afirmativamente a ítems como “estoy tenso” o “me siento alterado”) como negar su ausencia (EN; esto es, responder negativamente a ítems como “me siento calmado” o “me siento seguro”).
- Pese a que no hay notables diferencias se puede observar que los adolescentes de ambos sexos tiene puntuaciones más elevadas tanto en EA como en EN.



- c) En lo que respecta al sexo se puede observar que, si bien las diferencias no son muy elevadas, en ambos grupos las mujeres puntúan por encima de los varones en EA y EN.
- d) En el caso de la ansiedad rasgo (R) es difícil extraer conclusiones de las diferencias entre afirmación y negación de la ansiedad (RA y RN), dado que existen 13 elementos afirmativos (RA) y solo 7 elementos negativos de la misma (RN). No obstante, las tendencias existentes vuelven a replicar los mencionado para ansiedad estado, mayores puntuaciones en adolescentes que en adultos y en mujeres que en varones.

Así, pues, estos resultados añaden alguna luz explicativa a las diferencias intersexos (elevación de A/R en las mujeres) comentadas y documentadas en los apartados y párrafos anteriores. El fenómeno parece estar relacionado con los resultados encontrados en el estudio de otro cuestionario de personalidad (16 PF) que tiene una dimensión superior con este mismo nombre, Ansiedad; en el Apéndice A de la publicación de dichos resultados (Seisdedos, 1981) se comentan e ilustran estas diferencias interedades e intersexos, tanto a nivel de ese factor secundario (Ansiedad), como de sus componentes primarios o escalas C (Estabilidad), 0 (Aprensividad) y Q4 (Tensión energética o ansiedad flotante).

4. Normas interpretativas

4.1. Muestras de tipificación

Para la creación de los baremos de esta nueva edición y adaptación se utilizaron muestras de adolescentes, universitarios y adultos recogidas entre los años 2005 y 2010. Dado que la edad de los evaluados afecta a las puntuaciones directas del STAI se decidió, tal y como se hizo en la versión original, así como en la primera adaptación a lengua española, realizar baremos diferenciados por edad: adolescentes, universitarios y adultos.

En segundo lugar, dado que el sexo parece influir en las puntuaciones directas del STAI, incluso de forma más acentuada que la edad, se incluyeron baremos diferenciados para varones y mujeres. Así pues, en el proceso de tipificación y elaboración de los baremos se han formado los siguientes grupos, diferenciados por el sexo y edad:

- Adolescentes escolarizados en educación primaria o secundaria (hasta 19 años inclusive). Separados en varones y mujeres.
- Universitarios matriculados, separados en varones y mujeres.
- Adultos (mayores de edad). Separados en varones y mujeres.

La muestra de adolescentes está compuesta por 541 participantes entre los 11 y los 19 años, estando escolarizados en educación primaria o secundaria en el momento de la aplicación de la prueba. El muestreo fue incidental en los centros que accedieron a colaborar de diversas ciudades españolas e incluyó tanto centros públicos como privados. Un 57,3% de la muestra fue de mujeres ($n = 305$; edad media 15,3 años, $Dt = 1,6$) y un 42,7% de varones ($n = 227$; edad media 15,3, $Dt = 1,8$).

La muestra de universitarios está compuesta por 610 participantes entre los 17 y los 54 años, siendo alumnos matriculados en distintas carreras universitarias. Un 64,8% de la muestra fueron mujeres ($n = 395$; edad media 21,5 años, $Dt = 3,9$) y un 35,3% varones ($n = 215$; edad media 24,5; $Dt = 6,9$).

La muestra de adultos estuvo compuesta por 1.157 personas procedentes de diversas provincias españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Jaén, Madrid, Ourense, Santiago de Compostela y Valencia). El tipo de muestreo fue no probabilística por

cuotas que, en este caso, eran ser mayor de edad y no estar cursando una carrera universitaria en el momento de la aplicación del cuestionario. Para el muestreo se contó con la colaboración de organizaciones públicas y privadas. La edad se distribuye desde los 18 años hasta los 69 años de edad. La distribución por sexo fue:

- MUJERES: 693 (59,79% del total) cuya edad media fue de 29,39 años ($Dt = 9,85$).
- HOMBRES: 448 (40,21% del total) cuya edad media fue de 30,33 años ($Dt = 11,56$).

4.2. Conversión de valores directos en puntuaciones transformadas

Aunque en los estudios originales se utilizó como puntuación típica la escala T (media = 50, $Dt = 10$), en la tipificación original española se consideró más conveniente obtener las puntuaciones transformadas en las escalas de percentiles y decatipos. En esta nueva edición y adaptación se ha considerado adecuado respetar esta decisión, por lo que únicamente se presentarán las transformaciones a estas dos escalas (percentiles y decatipos).

La puntuación percentil indica el tanto por ciento del grupo normativo al que un sujeto determinado es superior en la variable apreciada por el test; los percentiles no forman una escala típica, sino ordinal, y no pueden emplearse para calcular promedios con los percentiles obtenidos en otras variables.

Las puntuaciones decatipos constituyen una escala típica de diez puntos (media = 5,50, desviación = 2) que puede ser fácilmente comprendida por el público en general.

Una vez obtenidas las puntuaciones directas mediante la suma de las respuestas en la copia del ejemplar autocorregible, y determinadas las características (sexo y edad) del sujeto cuyos resultados se van a interpretar, es fácil buscar en la tabla 10 de baremos las dos columnas (Estado y Rasgo) correspondientes a ese sexo y edad. En cada una de estas columnas se buscará la puntuación directa obtenida por el sujeto y, a la misma altura, horizontalmente, se encontrará la puntuación percentil en la primera columna de la izquierda y la puntuación decatipo en la columna final de la tabla.

No ha parecido conveniente la utilización de todos los percentiles, pues con ello se daría la impresión de una excesiva exactitud que el error de medida de la prueba no garantiza.

4.3. Obtención de puntuaciones en factores adicionales

Si bien la interpretación estándar de la prueba finaliza con la consideración de la doble faceta de estado-rasgo de la ansiedad informada por el sujeto, algunos profesionales pueden considerar interesante obtener las puntuaciones en las dimensiones definidas en el punto C del apartado 3.2 (Ansiedad Estado afirmativo, Ansiedad Estado negativo, Ansiedad



Rasgo afirmativo y Ansiedad Rasgo negativo). En estos casos, como método de aproximación a estas dimensiones subyacentes se puede utilizar el método indicado en el párrafo final del citado punto C: Utilizar la distinción mediante sombreado de los ítems para sumar las respuestas de los elementos afirmativos o negativos de cada subescala (Estado y Rasgo) y contrastar sus resultados con los que ofrece la tabla 9 obtenidos en la muestra de tipificación actual.

4.4. Grupos clínicos

Las puntuaciones directas obtenidas en el STAI por un sujeto que ha sido definido dentro de un determinado grupo clínico, apriorísticamente o mediante la utilización de otras técnicas, pueden ser interpretadas utilizando los baremos incluidos en la tabla 10 o aplicarle aquellos otros que puedan ser elaborados en el futuro para grupos específicos.

Cuando se utilicen los baremos de la tabla 10, la puntuación transformada de ese sujeto indicará su posición relativa a la población normal; podrá ser utilizada para observar variaciones en los distintos momentos de la aplicación de una terapia específica. Si el psicólogo dispone además de un número suficiente de casos clínicos de un determinado grupo, podrá elaborar el baremo correspondiente y utilizarlo como contraste en la labor clínica o de diagnóstico que realice en el futuro.

Tabla 10. Baremos en centiles y decatipos para ansiedad estado y rasgo. Adolescentes y Adultos, Varones y Mujeres

Percentiles	Puntuaciones directas												Decatipos
	Adolescentes				Universitarios				Adultos				
	Varones		Mujeres		Varones		Mujeres		Varones		Mujeres		
	Estado	Rasgo	Estado	Rasgo	Estado	Rasgo	Estado	Rasgo	Estado	Rasgo	Estado	Rasgo	
99	39-60	42-60	45-60	50-60	39-60	41-40	45-60	45-60	39-60	41-60	44-60	48-60	10
97	37-38	37-41	40-44	44	38	38-40	41-44	42-44	35-38	39-40	42-43	44-47	9
95	34-36	36	36-39	42	35-37	34-37	38-40	40-41	31-34	35-38	37-41	40-43	9
90	33	34-35	33-35	37-38	32-34	30-33	35-37	38-39	28-30	32-34	34-36	37-39	8
87	32	33	32	36	31	29	34	36-37	27	31	33	35-36	9
85	30-31	31-32	31	35	30	28	33	34-35	26	29-30	30-32	33-34	8
80	29	30	30	34	28-29	27	30-32	32-33	24-25	27-28	28-29	32	7
77	28	29	29	33	27	26	29	31	23	26	27	31	7
75	27	27-28	28	32	26	25	28	29-30	21-22	24-25	25-26	30	7
70	26	26	27	31	24-25	23-24	25-27	27-28	20	23	22-24	28-29	7
65	25	25	24-25	29-30	22-23	22	24	25-26	18-19	21-22	20-21	27	6
60	23-24	24	23	28	21	20-21	22-23	23-24	17	20	18-19	25-26	6
55	21-22	23	22	27	18-20	19	19-21	21-22	16	19	17	24	6
50	19-20	22	20-21	26	17	18	17-18	20	15	18	15-16	22-23	6
45	18	21	19	25	15-16	17	15-16	19	14	16-17	14	20-21	5
40	17	20	17-18	24	13-14	16	14	18	13	15	13	19	5
35	15-16	19	15-16	22-23	12	15	13	17	12	14	12	18	5
30	13-14	17-18	14	21	11	13-14	12	15-16	11	13	11	17	4
25	12	16	13	20	10	12	11	14	9-10	12	-	16	4
23	11	15	12	19	9	11	10	-	-	11	10	15	4
20	9-10	14	11	18	7-8	10	9	13	8	10	9	14	4
15	8	13	10	17	6	9	8	12	7	-	8	13	3
13	7	12	9	16	5	8	7	11	6	9	7	11-12	3
10	5-6	10-11	6-8	13-15	4	6-7	5-6	9-10	4-5	7-8	5-6	10	3
5	3-4	8-9	4-5	11-12	2-3	4-5	4	8	3	5-6	3-4	8-9	2
3	1-2	7	2-3	8-10	1	3	3	6-7	2	3-4	2	6-7	2
1	0	0-6	0-1	0-7	0	0-2	0-2	0-5	0-1	0-2	0-1	0-5	1
N	228	228	306	306	208	193	379	338	446	447	690	693	N
Media	19,80	22,29	20,92	26,24	18,44	19,02	20,01	22,45	16,25	18,98	18,32	23,37	Media
Desv. Típicas	10,04	8,63	10,57	8,91	11,09	9,49	11,47	10,57	9,65	9,75	11,33	10,45	Desv. Típica

Bibliografía

La siguiente es substancialmente una relación muy breve de las referencias que aparecen en la literatura aludiendo a aplicaciones y estudios con el STAI. Quien desee una ampliación de la misma podría consultar las obras o trabajos que se citan.

- Bermúdez Moreno, J. (1977). *Ansiedad y rendimiento*. Tesis doctoral no publicada. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Bermúdez Moreno, J. (1978a). Anxiety and performance. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 151, 183-207.
- Bermúdez Moreno, J. (1978b). Functional analysis of anxiety. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 153, 617-634.
- Guillén-Riquelme, A. y Buela-Casal, G. (en prensa). Actualización psicométrica y funcionamiento diferencial del ítem en el State Trait Anxiety Inventory (STAI). *Psicothema*.
- Muñiz, J. y Fernández-Hermida, J. R. (2010). La opinión de los psicólogos españoles sobre el uso de los tests. *Papeles del Psicólogo*, 31, 108-121.
- Sandín Ferrero, B. (1981). Consideraciones sobre el cuestionario 8SQ. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 169, 323-327.
- Seisdedos, N. (1981). *16PF. Monografía técnica*. Madrid: TEA Ediciones.
- Seisdedos, N. (1982). *Adaptación española del STAI – Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo* (1ª edición). Madrid: TEA Ediciones.
- Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L. y Lushene, R. E. (1970). *STAI. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Self-Evaluation Questionnaire)*. Palo Alto California: Consulting Psychologist Press.

- Spielberger, C. D., Lushene, R. E. y McAdoo, W. G. (1971). Theory and measurement of anxiety states. En R. B. Cattell (Ed.) *Handbook of Modern Personality Theory*. Chicago: Aldine.
- Urraca Martínez, S. (1981). *Actitudes ante la muerte (preocupación, ansiedad, temor) y religiosidad*. Tesis doctoral no publicada. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

La ansiedad se ha convertido hoy en día en uno de los principales problemas de salud de la sociedad industrializada y, como tal, se encuentra entre las primeras causas de la consulta médica o psicológica.

Un diagnóstico adecuado es crucial para establecer unas pautas de intervención eficaces. Este es el principal objetivo del cuestionario **STAI**, que evalúa dos conceptos independientes de la ansiedad, ansiedad como estado (E) y ansiedad como rasgo (R).

La brevedad del cuestionario, de tan solo 40 elementos y la sencillez de la corrección mediante un ejemplar autocorregible, hacen de la aplicación del **STAI** un proceso sencillo, ágil y extremadamente útil para los profesionales.

En esta nueva edición que ahora se presenta se ha procedido a una completa revisión de sus propiedades psicométricas y de sus baremos. A partir de una amplia muestra reciente de más de 1.500 casos se han generado nuevos baremos de adolescentes, universitarios y adultos que ven ampliadas y reforzadas su representatividad y vigencia. El conjunto de cambios introducidos en esta nueva edición esperamos contribuya a mantener el STAI como una de las pruebas más conocidas, utilizadas y valoradas por los profesionales.

www.teaediciones.com



Ediciones

ISBN 978-84-15262-26-8



9 788415 262268